

CLASE 1 – Adolescencia - introducción

1. Delimitación conceptual y contexto sociohistórico

La **adolescencia** es una etapa de transición del desarrollo humano, comprendida aproximadamente entre los 11 y los 19 o 20 años, caracterizada por profundas transformaciones en los planos físico, cognitivo, emocional y psicosocial. Es indispensable realizar una distinción epistemológica y conceptual entre dos términos frecuentemente confundidos:

- **Pubertad:** Es un proceso biológico, fisiológico y universal que culmina en la maduración de los órganos sexuales y la capacidad reproductora o fertilidad. Su curso es análogo en todas las culturas humanas.
- **Adolescencia:** Es un constructo social e histórico surgido a comienzos del siglo XX en las sociedades industrializadas de Occidente. En sociedades preindustriales, la transición de la niñez a la adultez era directa al alcanzarse la maduración física o el ingreso al trabajo. Aunque hoy la adolescencia es considerada un fenómeno extendido globalmente, sus formas de expresión, duración y significación varían ampliamente según los entornos culturales, económicos y normativos.

Factores que originaron la prolongación de la transición adolescente

La extensión de este período entre la infancia y la asunción de roles adultos plenos responde a transformaciones demográficas y socioeconómicas estructurales:

1. **Desincronización biológico-social:** Se produjo un adelanto progresivo en la edad de inicio de la pubertad (maduración biológica más temprana) junto a un retraso sistemático en la edad de contraer matrimonio y conformar una familia propia.
2. **Requerimientos de escolarización extendida:** La tecnificación y la economía del conocimiento exigen que los jóvenes acumulen más años de formación académica y destrezas complejas antes de acceder a un empleo estable.
3. **Transformaciones familiares y demográficas:** Incremento en las tasas de urbanización, aumento de la esperanza de vida, disminución de las tasas de natalidad (familias más reducidas) e inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo asalariado formal, lo cual reconfiguró las dinámicas de crianza y dependencia económica juvenil.

2. Procesos Endocrinológicos y Fisiológicos de la Pubertad

La pubertad es impulsada por una cascada neurohormonal que se despliega cronológicamente en dos grandes fases:

- **1. Adrenarquia (aproximadamente entre los 7 y 8 años):** Consiste en la maduración de la corteza de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas comienzan a secretar niveles crecientes de andrógenos, principalmente la dehidroepiandrosterona (DHEA). A los 10 años, los niveles de DHEA se multiplican por diez en relación con la primera infancia. Esta hormona interviene directamente en la aparición del vello púbico, axilar y facial inicial, la aceleración del crecimiento corporal, el incremento de la secreción sebácea en la piel (predisposición al acné) y la producción del olor corporal característico. Asimismo, hacia los 9 o 10 años suele experimentarse la primera atracción afectivo-sexual.
- **2. Gonadarquia:** Corresponde a la maduración de las gónadas primarias (ovarios y testículos) a partir de la activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Produce una segunda oleada masiva de DHEA hasta alcanzar concentraciones adultas:
 - *En mujeres:* Los ovarios incrementan la síntesis de estrógenos (predominantemente **estradiol**), estimulando el crecimiento de los genitales femeninos, el desarrollo mamario y el vello púbico y axilar.
 - *En varones:* Los testículos incrementan sustancialmente la secreción de andrógenos (particularmente **testosterona**), promoviendo el crecimiento de los genitales masculinos, el ensanchamiento muscular y el vello corporal.
 - *Principio fisiológico clave:* Ambos sexos producen tanto andrógenos como estrógenos; la diferenciación fenotípica radica en la proporción y predominio relativo de cada grupo hormonal en el organismo.

Características Sexuales Primarias y Secundarias

Categoría	Sexo Femenino	Sexo Masculino
Primarias (Órganos directamente indispensables para la reproducción)	Ovarios, trompas de Falopio, útero, vagina y clítoris.	Testículos, pene, escroto, vesículas seminales y próstata.
Secundarias (Signos fisiológicos de madurez sin función reproductiva directa)	Desarrollo de mamas (telarquia), vello púbico y axilar, modificación sutil del timbre de voz, textura de la piel, ensanchamiento y profundización de la pelvis ósea, depósito graso y desarrollo muscular.	Vello facial, púbico, axilar y corporal general, engrosamiento y cambio notorio en el tono de voz, cambios cutáneos (acné), mayor incremento de masa muscular y ensanchamiento del perímetro torácico y hombros.

Hitos de Maduración y Crecimiento Físico

- **Estirón puberal:** En niñas se inicia típicamente entre los 9.5 y 14.5 años (media alrededor de los 10), mientras que en varones ocurre entre los 10.5 y 16 años (media entre los 12 y 13). Se extiende por unos 2 años y es mediado por la interacción coordinada entre la hormona del crecimiento (GH) y los esteroides sexuales.
- **Espermarquia:** Primera eyaculación (frecuentemente manifestada a través de poluciones nocturnas involuntarias). Ocurre en promedio a los 13 años.
- **Menarquia:** Primera hemorragia menstrual, marcando el inicio de los ciclos ovulatorios potenciales. Se sitúa en un rango normal amplio entre los 10 y 16.5 años.

Tendencia Secular, Hipótesis de Grasa Crítica y Pubertad Precoz

La **tendencia secular** refiere al descenso continuo en la edad promedio de inicio de la pubertad y en el tiempo necesario para alcanzar la talla y madurez adultas a lo largo de las generaciones. Desde la perspectiva evolutiva, la pubertad responde a demandas y disponibilidades ambientales: mejores condiciones sanitarias, control de infecciones y nutrición adecuada envían señales de viabilidad metabólica. El desencadenamiento hormonal exige alcanzar un umbral de **grasa corporal crítica** (necesaria biológicamente para sostener energéticamente una gestación). Por ello, niñas con mayores porcentajes de tejido adiposo en la segunda infancia o con aumentos significativos de peso entre los 5 y 9 años presentan una activación puberal adelantada. Este fenómeno explica los picos de **pubertad precoz** (aparición de caracteres antes de los 8 años en niñas o 9 en varones) acentuados en contextos de confinamiento, sedentarismo y alteraciones dietarias.

3. Impacto Psicológico del Tiempo de Maduración (Timing Puberal)

El momento relativo en que ocurren los cambios corporales respecto al grupo de pares ejerce influencias psicosociales diferenciales según el género:

En Varones:

- *Maduración Temprana:* Suele asociarse con ventajas sociales iniciales (mayor estatura, fuerza y destreza atlética), lo que redundaría en mayor autoestima, popularidad y liderazgo. No obstante, investigaciones señalan que también pueden manifestar mayor ansiedad, rigidez por conformar expectativas adultas, impulsividad o vinculación temprana con pares desviados.
- *Maduración Tardía:* Tiende a generar sentimientos transitorios de inferioridad, cohibición, baja autoestima y percepción de rechazo o dominación por parte de compañeros de mayor porte físico.

En Mujeres:

- *Maduración Temprana:* Conlleva una mayor vulnerabilidad psicológica. El desarrollo precoz de formas corporales adultas genera desajuste con su nivel de madurez emocional y cognoscitiva. Se asocia con mayor insatisfacción con la imagen corporal, timidez, retracción social, y un riesgo incrementado de depresión, trastornos de conducta alimentaria (TCA), inicio precoz de la actividad sexual y conductas de riesgo.
- *Maduración Sincrónica o Tardía:* Suele vivenciarse con mayor comodidad y bienestar psíquico al acompañar el ritmo grupal normativo.

Principio de estrés acumulativo: El impacto psicológico del tiempo puberal es marcadamente más negativo cuando los cambios físicos coinciden en el tiempo con otras transiciones vitales estresantes (por ejemplo, el paso de la escuela primaria a la secundaria) o cuando se dan en contextos familiares y escolares de escasa contención.

4. Neurobiología del Cerebro Adolescente: Desarrollo Estructural y Funcional

La neurociencia contemporánea ha demostrado que el cerebro en la adolescencia está lejos de haber alcanzado su maduración definitiva; constituye un órgano en profunda reorganización funcional y estructural:

1. **Aumento de Sustancia Blanca:** Continúa la mielinización progresiva de los axones nerviosos en los lóbulos frontales, lo que incrementa notablemente la velocidad y eficiencia de la transmisión sináptica e interconecta regiones distantes de la corteza.
2. **Dinámica de la Sustancia Gris y Poda Sináptica:** Alrededor de la pubertad ocurre una sobreproducción transitoria de sinapsis en la corteza cerebral, seguida de una intensa *poda dendrítica* (eliminación de conexiones no utilizadas) que avanza desde las áreas sensoriales posteriores hacia la corteza prefrontal anterior. Las conexiones restantes se fortalecen y especializan mediante el principio neurobiológico dependiente del uso ("úsalo o piérdelo"). Las experiencias y estimulación cognitiva del adolescente esculpen activamente su arquitectura cerebral.
3. **Desbalance o Asincronía Fronto-Límbica:**
 - *Estructuras subcorticales límbicas (Amígdala):* Maduran tempranamente. En la adolescencia temprana (11 a 13 años), el procesamiento de estímulos emocionales y sociales recae predominantemente en la amígdala, responsable de reacciones afectivas intensas, instintivas y de alerta inmediata.
 - *Corteza Prefrontal (Lóbulos Frontales):* Encargada de las funciones ejecutivas (juicio reflexivo, planificación a largo plazo, evaluación costo-beneficio, autorregulación afectiva y control inhibitorio de impulsos), culmina su maduración de forma tardía, hacia los primeros años de la tercera década de vida.

Implicancias comportamentales y forenses: Este desfase cronológico entre un sistema límbico hipersensible a la recompensa y un sistema prefrontal inmaduro fundamenta la proclividad adolescente a la búsqueda de novedades, la vulnerabilidad a la presión de pares, los exabruptos emocionales y la dificultad para calibrar riesgos en situaciones de alta carga afectiva. Este sustrato neurocientífico es central en los debates actuales sobre responsabilidad jurídica e imputabilidad penal juvenil.

5. Salud Física, Ritmos Biológicos y Trastornos Psiquiátricos

Cronobiología del Sueño

Tras la pubertad se produce un retraso fisiológico en la secreción nocturna de **melatonina** (el marcador neuroendocrino inductor del sueño). Esto desplaza el reloj circadiano: el adolescente tiende a conciliar el sueño y a despertar naturalmente más tarde. Los horarios escolares matutinos provocan una privación crónica de sueño, deteriorando la consolidación de la memoria, el rendimiento académico y la regulación del estado de ánimo. Extender el sueño los fines de semana no repara el desbalance homeostático acumulado durante los días hábiles.

Imagen Corporal y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)

El aumento fisiológico de tejido graso en las mujeres puberales colisiona frecuentemente con los mandatos culturales de delgadez. Estudios prospectivos señalan que los comentarios de la familia y los modelos mediáticos ejercen una influencia reforzadora superior a la de los pares en la instauración de distorsiones de la imagen corporal.

Trastorno	Características Clínicas Principales	Signos de Alarma y Consecuencias
Anorexia Nerviosa	Obsesión por la delgadez, distorsión perceptiva severa de la propia silueta e inanición autoimpuesta (pudiendo coexistir con subtipos purgativos o ejercicio compulsivo). Muestra el índice de mortalidad y riesgo suicida más elevado entre todos los trastornos psiquiátricos.	Dietas secretas, descenso ponderal continuo con fijación de metas progresivamente más bajas, amenorrea (pérdida de menstruación), hipotermia, alopecia (caída de cabello) y aparición de vello corporal compensatorio (lanugo).
Bulimia Nerviosa	Episodios recurrentes de atracones compulsivos (consumo masivo de calorías en lapsos cortos de menos de 2 horas) seguidos de conductas compensatorias inapropiadas: vómitos autoinducidos, abuso de laxantes/diuréticos, ayunos severos o ejercicio extremo.	A diferencia de la anorexia clásica, las personas con bulimia suelen mantener un peso corporal dentro de rangos normales o presentar oscilaciones, dificultando su detección temprana.

Consumo de Sustancias

Las sustancias psicoactivas impactan sobre un cerebro en plena neurogénesis y reorganización sináptica, fijando patrones de dependencia:

- **Alcohol:** Genera daños neurotóxicos agudos y persistentes en el hipocampo y la corteza, comprometiendo la memoria y el aprendizaje. El inicio de consumo antes de los 15 años multiplica por cinco el riesgo de alcoholismo adulto en comparación con el inicio posterior a los 21 años.
- **Marihuana:** Afecta la memoria operativa, la velocidad de procesamiento, el juicio y la coordinación motriz. Posee potencial adictivo comprobado y desmitifica la creencia de inocuidad.
- **Fármacos de Prescripción:** Existe un incremento significativo en el uso indebido y no monitoreado de sedantes, ansiolíticos, estimulantes y analgésicos opioides.

Depresión en la Adolescencia

La semiología depresiva en la juventud difiere con frecuencia del cuadro adulto tradicional: suele enmascararse como **irritabilidad extrema, anhedonia (incapacidad de disfrutar), aburrimiento crónico u hostilidad** antes que como tristeza manifiesta.

Presenta mayor incidencia en mujeres debido a fluctuaciones neuroendocrinas puberales y estilos de afrontamiento relacional. El tratamiento de elección validado articula psicoterapia estructurada con **fármacos Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)**.

6. Mortalidad y Epidemiología del Suicidio

En la franja etaria de 10 a 19 años, las principales causas de fallecimiento son de índole externa:

1. **Siniestros viales:** Constituyen la primera causa de muerte traumática, con frecuencia agravados por la presencia de coetáneos en el vehículo (efecto de co-presencia de pares sobre la asunción de riesgos) y consumo de alcohol.
2. **Suicidio:** Es la segunda causa externa de muerte en adolescentes. En Argentina, registros oficiales del Ministerio de Salud (DEIS, 2022) constatan 3.221 suicidios totales anuales, de los cuales **394 correspondieron a adolescentes**.

Paradoja de género: Mientras que las mujeres registran significativamente mayor cantidad de tentativas o intentos de suicidio, los varones consuman el acto letal con mayor frecuencia debido al empleo de métodos de alta letalidad. A nivel neurobiológico, estudios post mortem han detectado anomalías estructurales y funcionales en las regiones de la corteza prefrontal encargadas de la inhibición conductual y el control del dolor psíquico.

7. Factores Protectores y Conectividad Vincular

Estudios poblacionales longitudinales a gran escala demuestran que la salud mental y la reducción de conductas de riesgo (violencia, abuso de sustancias, desregulación sexual) se sustentan en tres pilares ecológico-relacionales fundamentales:

- **Sentido de Conexión y Pertenencia:** Experimentar lazos significativos de afecto y valoración tanto en el seno familiar como en el entorno escolar.
- **Disponibilidad Parental Efectiva:** No solo presencia pasiva, sino tiempo compartido de calidad y accesibilidad emocional por parte de los cuidadores principales.
- **Calidez con Altas Expectativas de Logro:** La percepción de padres y docentes cálidos, comprensivos y continentales que, simultáneamente, sostienen estándares claros y expectativas positivas sobre las potencialidades del joven.

CLASE 2 – Adolescencia – desarrollo cognitivo

1. La Maduración Cognitiva: Modelo del Procesamiento de la Información

Durante la adolescencia, el funcionamiento mental experimenta un salto cualitativo y cuantitativo impulsado por la reorganización neuroestructural (maduración de los lóbulos frontales y circuitos frontoestriales). Estos avances se categorizan en cambios estructurales y cambios funcionales:

A. Cambios Estructurales

- **Expansión de la Memoria de Trabajo (Operativa):** Permite retener y manipular simultáneamente múltiples unidades de información complejas, facilitando la resolución de problemas multidimensionales y la toma de decisiones basada en diversas variables.
- **Incremento de la Capacidad y Velocidad de Procesamiento:** El flujo informacional es más rápido gracias a la mielinización axonal continua en las áreas frontales.
- **Enriquecimiento de la Memoria a Largo Plazo (MLP):** Se incrementa el volumen y la red de conocimientos organizados, divididos en tres dominios fundamentales:
 - *Conocimiento Declarativo ("Saber qué"):* Conjunto de hechos, datos y proposiciones fácticas adquiridas (por ejemplo, fórmulas matemáticas o fechas históricas).
 - *Conocimiento Procedimental ("Saber cómo"):* Habilidades motoras, cognitivas y destrezas ejecutivas automatizadas (por ejemplo, conducir un vehículo o resolver divisiones complejas).
 - *Conocimiento Conceptual ("Saber por qué"):* Comprensión abstracta y explicativa de principios y leyes subyacentes (por ejemplo, comprender por qué una igualdad algebraica se preserva al aplicar la misma operación en ambos miembros).

B. Cambios Funcionales

- **Optimización de Procesos Cognitivos:** Progreso en las capacidades de aprendizaje, evocación deliberada y razonamiento inferencial.
- **Desarrollo de las Funciones Ejecutivas (FF.EE.):** Mayor dominio de la atención selectiva y sostenida, planificación estratégica, autorregulación, control inhibitorio sobre impulsos inmediatos y flexibilidad cognitiva.
- **Metacognición:** Capacidad de reflexionar, monitorear, evaluar y ajustar conscientemente los propios procesos mentales y estrategias de aprendizaje ("pensar sobre el propio pensamiento"). Constituye uno de los avances cognitivos más determinantes de la etapa.
- **Paradoja del laboratorio vs. vida real:** Las ganancias ejecutivas evaluadas en contextos experimentales estructurados (cognición fría) no siempre se traducen linealmente en la toma de decisiones cotidianas (cognición caliente), donde el juicio suele verse interferido por la reactividad socioemocional, la búsqueda de recompensa y la presión del grupo de pares.

2. Teoría Operatoria de Jean Piaget: Estadio de las Operaciones Formales

Iniciado aproximadamente a partir de los 11 años, el estadio de las **operaciones formales** representa la cúspide del desarrollo cognoscitivo en el modelo piagetiano. Se define por la adquisición del **pensamiento abstracto** y la capacidad de operar lógicamente más allá de los datos inmediatos de la percepción.

Propiedades del Pensamiento Formal

- **Subordinación de lo real a lo posible:** El sujeto ya no está atado al "aquí y ahora". Concibe la realidad concreta como un subconjunto o caso particular dentro de un universo más amplio de transformaciones y posibilidades hipotéticas.
- **Diferenciación entre forma y contenido:** Es capaz de evaluar la validez lógica formal de un argumento con total independencia de si las premisas que lo componen son empíricamente verdaderas, falsas o desconocidas.
- **Manejo de lenguaje proposicional y simbolismo de segundo orden:** Capacidad de operar sobre símbolos que representan otros símbolos (como variables algebraicas x , y). Las proposiciones lingüísticas reemplazan a los objetos concretos.
- **Implicancias socioemocionales:** La abstracción permite estructurar ideales éticos, políticos y filosóficos. El adolescente puede comprometerse afectivamente con conceptos abstractos (amar la justicia y la libertad, o rebelarse ante la inequidad).

El Razonamiento Hipotético-Deductivo: La Tarea del Péndulo

Para evaluar la adquisición del pensamiento formal, Piaget e Inhelder diseñaron la clásica **tarea del péndulo**. El sujeto debe determinar qué variable física condiciona la frecuencia o velocidad de oscilación de un péndulo, considerando cuatro factores posibles: 1) *la longitud de la cuerda*, 2) *el peso del objeto suspendido*, 3) *la altura de caída*, y 4) *la fuerza del impulso inicial*.

Estadio del Sujeto	Estrategia de Resolución	Resultado y Nivel Lógico
Preoperacional (~7 años - Adam)	Acción puramente asistemática mediante ensayo y error (tanteo). Modifica cuerdas y pesos al azar sin plan previo.	Incapacidad de extraer conclusiones causales lógicas ni aislar variables.
Operaciones Concretas (~10 años - Adam)	Descubre que variar peso y longitud modifica la oscilación, pero varía múltiples factores de forma simultánea.	Confusión de variables: no logra disociar los factores ni determinar cuál de ellos es la causa determinante.
Operaciones Formales (~15 años - Adam)	Método científico sistemático: formula hipótesis exhaustivas y aísla sistemáticamente un factor manteniendo constantes los otros tres.	Razonamiento hipotético-deductivo exitoso: comprueba que únicamente la <i>longitud de la cuerda</i> determina la velocidad de oscilación.

Evaluación Crítica y Revisiones Neopietagianas

- **Universalidad cuestionada:** Entre un tercio y la mitad de los adolescentes y adultos en diversas sociedades no logran consolidar el estadio formal en los términos universales planteados originalmente por Piaget.
- **Dependencia contextual y de dominio:** El uso del razonamiento formal está estrechamente condicionado por la familiaridad del contenido, la pericia previa del sujeto, la instrucción formal escolar y la estimulación cultural específica. Quienes poseen capacidad abstracta no la aplican de forma homogénea en todos los problemas cotidianos.
- **Omisión de factores clave:** La teoría piagetiana original subestimó el rol de la metacognición, el incremento en la velocidad de procesamiento de la información y la interacción afectivo-contextual.

3. Manifestaciones de la Inmadurez del Pensamiento Adolescente (David Elkind)

David Elkind sostiene que muchas de las conductas conflictivas, paradójicas o egocéntricas de los adolescentes no provienen de déficits de razonamiento, sino de sus **intentos inexpertos por utilizar una herramienta cognoscitiva recién estrenada**: las operaciones formales. Al ensayar estas nuevas capacidades abstractas, el adolescente tropieza y manifiesta seis patrones típicos de inmadurez:

1. **Idealismo y Tendencia a la Crítica:** Al poder concebir construcciones utópicas o mundos ideales perfectos, contrasta violentamente esa abstracción con las imperfecciones de la realidad. Atribuye esta brecha a la incompetencia o hipocresía del mundo adulto, volviéndose hipercrítico frente a sus padres e instituciones de autoridad.
2. **Tendencia a la Discusión:** Busca permanentemente oportunidades para poner a prueba y exhibir sus destrezas lógicas. Discute y polemiza construyendo argumentos estructurados, defendiendo enfáticamente su postura personal.
3. **Indecisión:** La capacidad formal le permite proyectar un abanico infinito de cursos de acción y consecuencias simultáneas ante una situación; sin embargo, al carecer aún de estrategias eficaces de priorización y descarte, se paraliza incluso frente a elecciones cotidianas simples.
4. **Aparente Hipocresía:** Manifiesta una brecha marcada entre el plano discursivo y el conductual. Puede proclamar con vehemencia un principio ético o ecológico abstracto sin advertir la necesidad de asumir los costos prácticos, sacrificios personales o esfuerzos cotidianos para llevarlo a cabo.
5. **Autoconciencia (La Audiencia Imaginaria):** Estando intensamente focalizado en su propia transformación corporal y psicológica, asume de forma egocéntrica que todos los demás observadores están prestando exactamente la misma atención obsesiva a sus actos, vestimenta o detalles físicos que él mismo. Cree existir permanentemente bajo la mirada evaluadora de una "audiencia imaginaria".
6. **Suposición de Singularidad e Invulnerabilidad (La Fábula Personal):** Creencia egocéntrica de que su experiencia vital, dolor y vivencias son enteramente únicos e incomprensidos por el resto del mundo ("nadie sintió lo que yo siento"), acompañada por una ilusión de inmunidad frente a las leyes probabilísticas de la realidad ("a mí no me va a pasar"). Esta dimensión subyace de forma directa a conductas de alto riesgo.

4. Desarrollo del Lenguaje y Comunicación Social

El refinamiento del pensamiento abstracto transforma de manera decisiva la estructura lingüística y pragmática del adolescente:

- **Expansión del Léxico y Pensamiento Semántico:** Hacia los 16-18 años, el vocabulario promedio alcanza aproximadamente 80.000 palabras. El joven es capaz de definir, discernir y debatir conceptos de alta abstracción polisémica (justicia, lealtad, libertad, trascendencia).
- **Conectores Lógicos y Complejidad Sintáctica:** Incremento en el uso espontáneo de nexos argumentativos que expresan relaciones condicionales, concesivas y causales complejas ("*por el contrario*", "*en todo caso*", "*probablemente*", "*sin embargo*").
- **Meta-lenguaje y Recursión Simbólica:** Mayor dominio y disfrute del doble sentido, la ironía, los juegos lingüísticos, el sarcasmo, las alegorías y las metáforas complejas.
- **Toma de Perspectiva Social (Pragmática Comunicativa):** Habilidad para adaptar flexiblemente el registro discursivo y el nivel de sofisticación lingüística según el punto de vista, edad y conocimientos del interlocutor, facultad indispensable para la negociación, la persuasión eficaz y la diplomacia social.
- **Pubilecto (Jerga Adolescente):** Dialecto o código lingüístico intragrupal propio que cumple una doble función psicosocial: consolida el sentido de pertenencia e identidad entre pares y delimita una frontera identitaria diferenciadora respecto al mundo adulto.

CLASE 3 – Adolescencia - Moral

1. La Teoría del Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg

Lawrence Kohlberg concibe el desarrollo moral como un proceso cognitivo-evolutivo estructurado en estadios universales, invariables y jerárquicos. A través del planteo de dilemas morales hipotéticos (como el clásico *Dilema de Heinz*: el esposo que debe decidir si robar un fármaco sobrevaluado para salvar la vida de su esposa enferma de cáncer), Kohlberg evalúa la estructura del razonamiento y la justificación lógica subyacente al juicio, más allá de la decisión conductual concreta tomada.

Nivel y Rango Etario	Estadio	Criterio de Corrección Moral	Perspectiva Social y Razón para Actuar
Nivel I: Preconvencional (4 a 10 años aprox. Reglas externas internalizadas solo por consecuencias físicas directas)	Estadio 1: Orientación hacia el castigo y la obediencia	Lo correcto se define por la evitación del daño físico o castigo. Se ignoran los motivos subjetivos del agente.	<i>Egocéntrica:</i> No diferencia el punto de vista propio del ajeno; sumisión incondicional al poder de la autoridad.
	Estadio 2: Propósito instrumental e intercambio individualista	Lo correcto es lo que satisface las propias necesidades instrumentales ("un favor por otro").	<i>Individualista concreta:</i> Reconoce que los otros tienen intereses propios que pueden chocar; intercambio pragmático.
Nivel II: Convencional (10 a 13 años / adolescencia tardía. Adopción de normas grupales y mantenimiento del orden social)	Estadio 3: Expectativas interpersonales ("Buen chico / Buena chica")	Ser moral implica tener buenas intenciones, ser empático, cumplir expectativas de los vínculos cercanos y mantener la confianza mutua (Regla de Oro).	<i>Relacional:</i> Pone las expectativas y sentimientos compartidos por encima del interés puramente individual.
	Estadio 4: Sistema social y conciencia ("Ley y orden")	Cumplir estrictamente con el deber institucional, respetar la autoridad constituida y preservar el orden normativo general para evitar el colapso social.	<i>Sistémica:</i> Diferencia el sistema legal/institucional global de los acuerdos interpersonales directos.
Nivel III: Posconvencional (Adolescencia tardía, adultez temprana o nunca. Principios morales autónomos y universales)	Estadio 5: Contrato social y derechos individuales	Las leyes se conciben como acuerdos revisables. Si la ley entra en conflicto con derechos fundamentales (la vida humana), prevalece el derecho universal.	<i>Previa a la sociedad:</i> Perspectiva de un sujeto racional que reconoce valores éticos anteriores al contrato civil.
	Estadio 6: Principios éticos universales	Fidelidad a principios de justicia, igualdad y dignidad humana autoelegidos e internalizados, válidos aun contra normas legales positivas vigentes.	<i>Universal / Kantiana:</i> Se concibe a cada ser humano como un fin en sí mismo y nunca como mero medio instrumental.

Evaluación Crítica y Límites del Modelo Racionalista Clásico

- **Desarrollo Cognitivo vs. Moral:** Un nivel avanzado de maduración cognitiva formal es una condición *necesaria pero no suficiente* para alcanzar niveles morales postconvencionales.
- **Disociación entre Razonamiento y Comportamiento Moral:** La sofisticación argumentativa abstracta no garantiza conductas prosociales efectivas; intervienen variables afectivas, motivacionales y situacionales.
- **Inconsistencia Transituacional y Crítica de Krebs y Denton:** Sujetos que razonan en Estadío 5 ante dilemas hipotéticos formales descienden a Estadío 2 (intercambio instrumental egocéntrico) ante dilemas reales de negocios, conducción bajo alcohol o cuando media un interés personal en juego. La distinción post-hoc de Kohlberg entre competencia y desempeño fue criticada por volver el modelo infalseable.
- **Críticas de Carpendale, Kraus y Coleman:** Carpendale señala la falacia del concepto de *structure d'ensemble* (estructura totalitaria indiferenciada), demostrando que la moral es un proceso dinámico de coordinación de perspectivas contextualmente situadas. Kraus y Coleman argumentan la incompatibilidad lógica de derivar la moral de la pura racionalidad maximizadora de utilidad.
- **Sesgo Cultural y de Género:** Críticas transculturales demostraron que el modelo sobrepondra los valores individualistas y de justicia occidentales, subestimando morales basadas en el deber comunitario, la lealtad grupal o la ética del cuidado.

2. Nuevas Perspectivas en Psicología Moral y Neurociencia

A. El Giro Intuicionista y la Teoría de los Fundamentos Morales (Jonathan Haidt)

Haidt (2001) propone que el juicio moral es primariamente el resultado de **intuiciones afectivas rápidas y automáticas**, mientras que el razonamiento consciente opera de forma retrospectiva (*post-hoc*) como un "abogado defensor" que busca justificar la respuesta intuitiva previa.

- **Moral Dumbfounding (Desconcierto Moral):** Ocurre cuando una persona juzga una acción como moralmente incorrecta (por ejemplo, el escenario de incesto consentido, protegido con anticonceptivos y sin daño colateral) y, al ser desarmados todos sus argumentos fácticos racionales, mantiene el rechazo moral sentenciando: *"no sé por qué, pero simplemente está mal"*.
- **Teoría de los Fundamentos Morales (MFT - Haidt & Graham):** Amplía el espectro moral más allá de la justicia kohlbergiana a seis matrices evolutivas: 1) Cuidado/Daño, 2) Justicia/Engaño, 3) Lealtad/Traición, 4) Autoridad/Subversión, 5) Pureza/Degradación, y 6) Libertad/Opresión.

B. Teoría del Procesamiento Dual (Joshua Greene)

Distingue entre dos sistemas neurocognitivos diferenciados según la naturaleza del dilema:

- **Dilemas Morales Personales (Intervención física directa / alta saliencia afectiva):** Activan circuitos socioemocionales (Corteza Frontal Medial, Circunvolución Cingulada Posterior, Surco Temporal Superior), produciendo rechazos deontológicos inmediatos.
- **Dilemas Morales Impersonales:** Reclutan áreas del control cognitivo y razonamiento de memoria de trabajo (Corteza Prefrontal Dorsolateral, Lóbulo Parietal), favoreciendo análisis consecuencialistas o utilitaristas (costo-beneficio).
- *Metaanálisis de Sevinc y Spreng (2014):* Diferenció entre tareas de **razonamiento moral activo** (deliberación explícita) y **emoción moral pasiva** (reacciones afectivas automáticas ante escenas moralmente densas).

C. Modelo de Integración Cognitivo-Emocional-Cultural (Moll et al., 2005)

Plantea que la moral emerge de la convergencia funcional dinámica de tres componentes representacionales en el cerebro:

1. **Conocimiento Contextual Situacional:** Eventos contextuales almacenados en la corteza prefrontal.
2. **Conocimiento Semántico Social:** Esquemas y roles sociales procesados en la corteza temporal anterior y posterior.
3. **Estados Motivacionales y Emocionales Básicos:** Circuitos córtico-límbicos subcorticales.

Moll y su equipo definen la moralidad como el conjunto de costumbres y valores adoptados por un grupo cultural para guiar la conducta comunitaria, descartando la existencia de principios absolutos descontextualizados.

3. Experiencia Escolar y Factores del Rendimiento Académico

La escuela constituye un escenario ecológico integral: no solo instruye el intelecto que razona, sino que modela la subjetividad vincular y vocacional del adolescente.

Motivación, Autoeficacia y Autodisciplina

- **Autoeficacia Percibida (Bandura):** La convicción del estudiante respecto a su propia capacidad para dominar materias y autorregular su aprendizaje constituye el predictor directo más robusto de las calificaciones futuras, superando la expectativa pasiva.
- **Autodisciplina vs. Inteligencia:** Investigaciones longitudinales demuestran que la disciplina personal y la autorregulación duplican la capacidad predictiva del Coeficiente Intelectual (CI) sobre el rendimiento escolar efectivo.
- **Divergencias Culturales de la Motivación:** Mientras Occidente enfatiza la motivación intrínseca subjetiva, en culturas orientales (Asia Oriental) el éxito escolar responde al deber moral, la sumisión a la autoridad y la responsabilidad filial, concibiendo al aprendizaje como un proceso de esfuerzo persistente ante el error.

Factores Protectores de la Permanencia Escolar

- Nivel socioeconómico (NSE) medio/alto y elevado nivel educativo formal de los progenitores.
- Ambiente familiar con capital cultural acumulado (estimulación lectora, наличие de libros en el hogar).
- Pertenencia a grupos de pares orientados al logro académico y valoración positiva de la institución educativa.
- *Brechas de Género:* Las mujeres mantienen ventajas sistemáticas en comprensión lectora y producción escrita, mientras que la brecha tradicional masculina en matemáticas y ciencias se ha reducido a medida que las mujeres acceden a cursos de igual exigencia académica.

4. Estilos de Crianza Parental e Impacto Educativo

Estilo de Crianza	Pautas Vinculares y de Control	Impacto en el Rendimiento Académico
Democrático / Autoritativo	Articula alta exigencia con alta receptividad afectiva. Estimula el debate abierto, involucra a los hijos en decisiones, elogia los logros y ante bajas calificaciones ofrece contención y ayuda pedagógica.	Resultados óptimos: Máximo nivel de autoeficacia, compromiso intrínseco con el estudio y adaptabilidad psicosocial.
Autoritario	Alta exigencia sin receptividad ni calidez. Desalienta el cuestionamiento ("las reglas no se discuten"), recurre al castigo punitivo y atribuye las malas notas a negligencia o falta de esfuerzo del joven.	Genera ansiedad de desempeño, dependencia del control externo y riesgo de deserción o frustración ante el fracaso.
Permisivo / Indulgente	Ausencia de normas y límites; desatención o indiferencia hacia las trayectorias escolares bajo la premisa de que "el adolescente debe hacerse cargo de su propia vida".	Bajo rendimiento académico, dificultades de autorregulación y escasa persistencia ante tareas desafiantes.

5. Trayectorias Educativas, Deserción y Datos Estadísticos

Dinámica Institucional y Abandono Escolar

El abandono escolar responde a factores multidimensionales: marginalidad socioeconómica, planes de estudio desconectados del contexto cultural, prácticas de segregación por rendimiento académico (*tracking*) que estigmatizan a los grupos vulnerables y expectativas docentes empobrecidas (efecto Pigmalión negativo). Quienes desertan enfrentan mayores índices de desempleo, subempleo informal, precariedad en la salud física y mental, y vulnerabilidad ante conductas delictivas.

Datos Epidemiológicos de Argentina (Observatorio de Argentinos por la Educación, Cohorte 2016-2022)

El seguimiento longitudinal de estudiantes desde los 11 años (2016) hasta los 17 años (2022) evidencia un desgranamiento crítico de la trayectoria secundaria formal:

- A los 12 años (2017): El 85,9% cursa en edad teórica esperada; el abandono se sitúa en apenas el 1,0%.
- A los 14 años (2019): La proporción en edad teórica desciende al 70,0% y la repitencia acumulada asciende al 26,5%.
- A los 17 años (2022): **Solo el 59,5% llega en edad teórica normada**, mientras que el **abandono escolar directo trepa al 15,1%** y el 25,4% restante presenta entre 1 y 3 años de sobreedad o repitencia.

6. Proyecto de Vida, Inserción Laboral y Género en Áreas STEM

Modelos Comparados de Transición Ocupacional

- **Sistema Dual Alemán:** Articula formación pedagógica formal con aprendizaje técnico remunerado en empresas bajo estricta tutoría institucional. Participa el 60% de los estudiantes de educación media superior y alcanza un 85% de inserción laboral formal directa al egreso.
- **Modelo Estadounidense:** Orientado casi exclusivamente a la transición hacia la universidad. Los programas técnicos no universitarios presentan menor articulación con el mercado laboral productivo.
- **Tipología del Trabajo Adolescente:**
 - *Aceleradores:* Trabajan más de 20 horas semanales. Suelen abandonar las metas académicas, aceleran de forma no contenida la vida adulta y presentan mayor riesgo de consumo problemático de sustancias.
 - *Equilibradores:* Trabajan a tiempo parcial de forma acotada. Desarrollan hábitos de responsabilidad, autonomía y autovaloración sin desatender sus trayectorias educativas superiores.

Brechas de Género y Segregación Vertical en el Ámbito Científico (CONICET - Argentina)

En la elección de carreras (orientación vocacional), persisten barreras culturales, ausencia de modelos de rol y estereotipos que desalientan el ingreso femenino a disciplinas **STEM** (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Aunque la base científica muestra paridad o prevalencia femenina global (53,74% de investigadoras en CONICET), se observa un marcado fenómeno de **techo de cristal / segregación vertical**:

Categoría de la Carrera del Investigador	Mujeres	Hombres	Tendencia Estructural
Asistente e Inicial	1.779 (60,1%)	1.178 (39,8%)	Mayoría femenina en los tramos de ingreso formativo.
Adjunto	2.430 (58,6%)	1.713 (41,3%)	Predominio femenino sostenido en categorías intermedias.
Principal	600 (42,8%)	803 (57,2%)	Inversión de la correlación: predominio masculino en rangos de toma de decisión.
Superior (Máxima jerarquía)	47 (25,7%)	136 (74,3%)	Techo de cristal manifiesto: 3 de cada 4 investigadores en la cúspide jerárquica son varones.

CLASE 4 – Adolescencia - Identidad

1. La Formación de la Identidad: Modelos Teóricos Clásicos y Contemporáneos

La **identidad** se define como una concepción coherente, diferenciada y unificada del yo (*self*), integrada por metas, valores, ideologías y creencias con las cuales el sujeto establece un compromiso personal firme y duradero (Erikson, 1950). El desarrollo de las operaciones formales permite al adolescente construir una verdadera "teoría del yo" (Elkind), integrando los logros de las etapas previas (confianza, autonomía, iniciativa e industriiosidad) para afrontar las demandas de la adultez.

A. Modelo Epigenético de Erik Erikson: Identidad vs. Confusión de Identidad

La quinta crisis del ciclo vital eriksoniano se resuelve a partir de tres elecciones cruciales: **1) la elección de una ocupación o vocación**, **2) la adopción de un sistema ético-ideológico y de valores**, y **3) el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria**.

- **Moratoria Psicosocial:** Período normativo de libertad y postergación de exigencias adultas plenas que la sociedad concede al adolescente para ensayar roles, explorar alternativas y hallar compromisos genuinos. Cuando este espacio se anula (imposición de adultez prematura), el sujeto cae en confusión de identidad o conductas disfuncionales.
- **Virtud Emergente - La Fidelidad:** Es la lealtad sostenida, la fe y el sentido de pertenencia hacia un conjunto de valores, una vocación, una ideología política, religiosa o hacia personas significativas. Constituye una extensión madurativa de la confianza básica infantil, ahora volcada hacia la confianza en uno mismo y en ideales compartidos.
- **Confusión de Identidad / Rol:** Peligro central de la etapa. Se manifiesta como aislamiento, incapacidad para planificar el futuro ocupacional, susceptibilidad extrema a la masificación o adopción de identidades negativas/delictivas como forma de fijar un sentido del yo.

B. Estados de Identidad de James Marcia: Dinámica de Crisis y Compromiso

Marcia operacionaliza la teoría eriksoniana a partir de dos variables: la **crisis** (período consciente de deliberación, búsqueda y exploración de alternativas) y el **compromiso** (inversión personal y adhesión firme a una ocupación o ideología). Estos estados no son etapas lineales fijas, sino momentos dinámicos del desarrollo del *self*:

Estado de Identidad	Variables Definitorias	Dinámica Familiar Típica	Características de Personalidad y Ajuste
Logro de Identidad (Ej. Catalina)	Crisis superada + Compromiso firme	Padres democráticos que fomentan la autonomía y la expresión de diferencias en un clima de mutualidad afectiva.	Alto desarrollo del yo, razonamiento moral autónomo, alta autoestima, seguridad personal y capacidad para la intimidad madura.
Exclusión / Cierre Hipotecado (Ej. Andrea)	Compromiso sin Crisis previa (adopción pasiva de planes ajenos)	Familias sobreinvolucradas o autoritarias donde se desalienta o penaliza la diferenciación individual.	Tendencia al autoritarismo, pensamiento dogmático/estereotipado, sumisión a la autoridad, dependencia emocional y baja ansiedad aparente.
Moratoria (Ej. Nicolás)	Crisis activa en curso / Sin Compromiso definitivo	Lucha ambivalente con la autoridad paterna; renegociación de límites.	Nivel elevado de ansiedad y conflicto interno, alta vitalidad reflexiva, buen desarrollo moral y sensibilidad psicosocial.
Difusión de Identidad (Ej. Marcos)	Sin Crisis + Sin Compromiso (desinterés o evitación)	Crianza indiferente, negligente o padres no disponibles emocionalmente.	Baja complejidad cognitiva, fragilidad en el sentido del yo, escasa cooperación, apatía o deriva comportamental.

C. Avances Contemporáneos: Identidad Narrativa y Micro-cambios Cotidianos

Investigaciones recientes (Crocetti, 2026; Luyckx et al., 2023; McAdams, 2021) reformulan la conceptualización clásica:

- **Identidad vs. Personalidad (McAdams):** La personalidad aporta rasgos disposicionales básicos, pero la identidad constituye una *identidad narrativa* internalizada que confiere unidad, propósito y sentido biográfico a dichos rasgos en el marco social.
- **Micro-procesos Cotidianos y Plasticidad:** La identidad no se resuelve en una única macro-crisis adolescente; se consolida mediante micro-compromisos y reevaluaciones diarias. Presenta una alta plasticidad frente a intervenciones psicoeducativas y comunitarias.

D. Género y Etnicidad en la Identidad

- **Crítica de Carol Gilligan:** Sostuvo que el modelo eriksoniano tradicional prioriza la autonomía individual masculina (la identidad precede a la intimidad). En las mujeres, el yo se estructura en y a través de los vínculos relacionales (ética del cuidado); la identidad y la intimidad se desarrollan de forma coextensiva y simultánea.
- **Identidad Racial/Étnica:** Se organiza en estados análogos (difusión, exclusión, moratoria y logro étnico). La *socialización cultural positiva* en el hogar amortigua el impacto del racismo ambiental y fortalece el rendimiento académico.

2. Sexualidad, Diversidad y Salud Integral

A. Dimensiones de la Identidad Sexual (Modelo Genderbread Person)

La vivencia de la sexualidad integra cuatro componentes analíticamente independientes que no pueden reducirse a determinismos biológicos o culturales unidireccionales:

1. **Identidad de Género:** Vivencia interna y psicológica individual del género (autopercepción de feminidad, masculinidad o identidades no binarias).
2. **Expresión de Género:** Manifestación externa del género mediante la vestimenta, conducta y estilo comunicacional.
3. **Sexo Anatómico / Asignado al Nacer:** Características biológicas, cromosómicas y gonadales.
4. **Orientación Sexual y Afectiva:** Dirección de la atracción erótica, romántica y afectiva (hacia personas del mismo sexo, opuesto, ambos o ninguno).

B. Diversidad Sexual, Heteronormatividad y Salud Mental

La cultura heteronormativa asume que sexo biológico, identidad de género y orientación heterosexual deben alinearse obligatoriamente. La evidencia científica acumulada establece que **las identidades LGBTQ+ no constituyen patologías mentales en sí mismas**.

- **Riesgo Suicida y Violencia Social:** Adolescentes LGBTQ+ exhiben una **probabilidad de suicidio hasta 4 veces mayor** que sus pares heterosexuales (Fundación Todo Mejora, 2013). Esta disparidad es producto directo del estrés de minorías: hostigamiento escolar (bullying), rechazo intrafamiliar, violencia institucional y desamparo estatal.
- **Factores Protectores Específicos:** La aceptación familiar activa, la pertenencia a redes comunitarias de pares diversos y la visibilidad de modelos positivos neutralizan la sintomatología ansiosa y restituyen el bienestar psicosocial.

C. Epidemiología de la Conducta Sexual, Descenso del Embarazo y Problemáticas en Argentina

- **Iniciación Sexual (3ª Encuesta Mundial de Salud Escolar):** El 42% de los escolarizados de 13 a 17 años declara haber iniciado su vida sexual (31,8% entre 13-15 años y 63,7% entre 16-17 años). Más del 90% de los embarazos tempranos no son intencionales.
- **Paradoja Preventiva y Preservativos:** Solo el 14,5% de la población general y apenas el **5% de los adolescentes utiliza preservativo de forma sistemática** en todas sus relaciones sexuales. Esto condujo a un aumento crítico de Infecciones de Transmisión Sexual (46.613 casos de sífilis en 2025, un incremento del 71% respecto a la mediana previa; 98% de nuevos diagnósticos de VIH ligados a sexo desprotegido).
- **Descenso del Embarazo Adolescente en Argentina:** La tasa de fecundidad adolescente se redujo en más de un 60% (de 117.386 nacimientos en menores de 20 años en 2013 a 46.236 en 2021; la tasa cayó de 22,6 por mil en 2016 a 6,7 en 2021). Factores explicativos: acceso masivo a métodos anticonceptivos de larga duración (implantes subdérmicos/chips), asesorías en salud sexual y aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI N° 26.150).
- **Impacto de la Pornografía Digital Temprana:** El 50% de los jóvenes de 11 a 13 años ya consumió pornografía en la web y un 76% accede a contenidos que normalizan prácticas violentas o asimétricas, distorsionando la construcción de los vínculos erótico-afectivos.

3. Dinámica Relacional: Familia, Individuación y Grupo de Pares

A. Desmitificación de la "Rebelión Adolescente"

Frente a las posturas tradicionales de G. Stanley Hall y el psicoanálisis clásico (Freud y Anna Freud), que concebían a la adolescencia como una etapa universal e inevitable de "tormenta y tensión" (*Sturm und Drang*), investigaciones transculturales (desde Margaret Mead) demuestran que **solo 1 de cada 5 jóvenes experimenta turbulencia extrema**. La mayoría mantiene lazos afectuosos con sus padres y coincide en valores éticos esenciales.

B. Individuación, Autorrevelación y Estilos de Crianza

- **Proceso de Individuación:** Lucha por la diferenciación psíquica y el establecimiento de fronteras entre el yo y los progenitores. Los roces cotidianos expresan esta renegociación del poder.
- **Control Conductual vs. Control Psicológico:** Los padres democráticos ejercen *control conductual* (reglas claras, conocimiento de actividades y límites firmes), lo cual protege al joven. En contraste, el *control psicológico* (manipulación emocional, inducción de culpa y retiro del afecto) anula la autonomía y deteriora gravemente la salud mental adolescente.
- **Autorrevelación Adolescente:** La supervisión eficaz no depende del espionaje parental, sino de la disposición voluntaria del adolescente a comunicar sus vivencias. Revelan más sobre cuestiones prudenciales (drogas, seguridad) y morales, reservando la privacidad en sus asuntos personales.

C. Vínculos con Hermanos y Estructuras del Grupo de Pares

Dimensión Vincular	Dinámica Evolutiva y Funciones Psicosociales
Relación Fraternal	Se vuelve más simétrica y equitativa; disminuye la proximidad diaria. Un hermano mayor prosocial modela conductas protectoras, pero la convivencia con un hermano con conductas delictivas o de adicción incrementa significativamente el riesgo.
Amistades Diádicas	Máxima reciprocidad, intimidad emocional, autorrevelación y lealtad (especialmente acentuada entre mujeres).
Pandillas y Coaliciones	<i>Pandillas</i> : Grupos cerrados basados en actividades compartidas y estatus. <i>Coaliciones (Crowds)</i> : Agrupaciones basadas en reputación social e imagen colectiva (ej. deportistas, populares, intelectuales). La susceptibilidad a la presión de pares alcanza su pico a los 12-13 años y declina hacia el final de la etapa.
Vínculos Románticos	Evolucionan desde encuentros en grupos mixtos hacia parejas diádicas exclusivas e íntimas. Las rupturas amorosas tempranas constituyen un factor precipitante de cuadros depresivos agudos y crisis suicidas.

4. Conducta Antisocial, Delincuencia y Transición a la Adulthood Emergente

A. Factores Ecológicos de la Delincuencia Juvenil

- **Bases Neurobiológicas:** Heredabilidad genética (40-65% de la varianza en agresión) asociada a inmadurez en los circuitos prefrontales inhibitorios y alteración en la respuesta al estrés.
- **Contagio de Pares Desviados (Deviant Peer Contagion):** Dinámica grupal donde adolescentes problemáticos refuerzan mutuamente actitudes transgresoras. Por ello, agrupar jóvenes delincuentes en entornos cerrados suele ser contraproducente.
- **Trayectorias:** La delincuencia presenta un pico alrededor de los 15 años y tiende a remitir espontáneamente. Solo la delincuencia de inicio temprano en la niñez con déficit familiar severo persiste hacia el crimen crónico adulto.

B. La Adulthood Emergente (Jeffrey Arnett)

Período evolutivo de transición (18 a 25/29 años) propio de sociedades posindustriales. La adultez ya no se define por hitos externos (casarse, tener hijos), sino por **criterios subjetivos internos**: 1) asumir la responsabilidad de las propias acciones, 2) tomar decisiones con criterio autónomo, y 3) alcanzar la autosuficiencia económica.

CLASE 5 - Adultez

1. Epistemología del Desarrollo Adulto y Marco del Ciclo Vital (Paul B. Baltes)

Frente a las posturas tradicionales reduccionistas (como la de Sigmund Freud, que situaba el fin del desarrollo psicosexual en la pubertad y concebía a las etapas posteriores como mera repetición o declive), la psicología contemporánea ha consolidado el estudio del desarrollo adulto en los últimos 70 años bajo el paradigma del **ciclo vital (Life-Span Development)**.

Distinción Conceptual Clave: Cambio vs. Desarrollo

- **Cambio:** Simple variación o diferencia de estado que experimenta un organismo o situación de un momento temporal a otro (puede ser aleatorio, transitorio o desorganizado).
- **Desarrollo:** Proceso *sistemático* (coherente, estructurado y organizado) de *cambio adaptativo* en el comportamiento en una o más direcciones, que permite al sujeto afrontar las condiciones cambiantes internas (biológicas) y externas (ambientales). Emerge de la interacción dialéctica constante entre la maduración neurobiológica y el aprendizaje experiencial.

Principios del Enfoque del Ciclo Vital (Baltes, 1987)

1. **El desarrollo dura toda la vida:** Ningún período ontogenético es intrínsecamente superior o más relevante que otro; cada fase posee su propio valor funcional, está condicionada por los logros precedentes y sienta las bases para las etapas subsiguientes.
2. **Dependencia histórica y contextual:** El sujeto es modelado por su tiempo histórico, coordenadas geográficas y cultura, al tiempo que actúa transformando activamente dichos entornos ecológicos.
3. **Multidimensionalidad y Multidireccionalidad:** El desarrollo no es una curva homogénea de ascenso o descenso. Involucra un balance constante de ganancias (crecimiento) y pérdidas (declive). Mientras ciertas funciones declinan (ej. velocidad de procesamiento de problemas no familiares), otras se expanden (ej. vocabulario, pragmática, conocimiento experto y sabiduría). El individuo busca maximizar ganancias y minimizar o compensar pérdidas mediante estrategias adaptativas (modelo SOC: Selección, Optimización y Compensación).
4. **Plasticidad relativa o flexibilidad:** Capacidad neurobiológica y conductual para modificar y optimizar el desempeño a través del entrenamiento, la estimulación cognitiva y el ejercicio, aun en la vejez avanzada, aunque dentro de ciertos límites biológicos fijados.
5. **Causalidad múltiple / Enfoque multidisciplinar:** El desarrollo no puede explicarse por una sola disciplina; requiere la concurrencia de la biología, la psicología, la sociología, la antropología y la neurociencia.

2. Constructos de Edad y Períodos del Desarrollo Adulto

Dimensiones Múltiples de la Edad

La edad cronológica (tiempo transcurrido desde el nacimiento) es un índice cuantitativo insuficiente para predecir el funcionamiento real de un adulto. Se operacionalizan cuatro dimensiones interdependientes:

- **Edad Funcional:** Capacidad de una persona para desempeñarse e interactuar de forma autónoma en su entorno físico y social en comparación con sus pares de la misma cohorte cronológica. Evalúa la competencia en Actividades de la Vida Diaria (AVD).
- **Edad Biológica:** Estado fisiológico y vital de los órganos y sistemas corporales (cardiovascular, respiratorio, inmunológico). Puede modificarse favorablemente mediante hábitos saludables o acelerarse por patologías.
- **Edad Psicológica:** Capacidad cognitiva, afectiva y conductual para adaptarse y responder eficazmente a las demandas y estresores del ambiente (ej. pérdidas afectivas, transiciones de rol, accidentes).
- **Edad Social:** Grado en que el comportamiento y los roles del individuo se ajustan a las expectativas y normas sociales asignadas para su franja etaria dentro de una cultura (el "reloj social").
- *El constructo de "Yo Intemporal" y Edad Cognitiva (Edith Labos):* Percepción subjetiva en la adultez media y tardía de que la identidad nuclear permanece intacta ("sentirse más joven de lo que marca el documento"), lo que preserva la autoestima y el bienestar subjetivo.

Períodos de la Adulthood

Período	Desarrollo Físico	Desarrollo Cognitivo	Desarrollo Psicosocial
Adulthood Joven (20 a 40 años)	Cima de la vitalidad física, fuerza, resistencia y agudeza sensorial. Hacia el final del período se inician ligeros declives imperceptibles. Las elecciones de estilo de vida sientan las bases de la salud futura.	Pensamiento posformal: razonamiento más flexible, dialéctico, pragmático e integrador de contradicciones morales y contextuales. Elecciones vocacionales.	Estabilización de rasgos de personalidad. Construcción de relaciones íntimas profundas (intimidad vs. aislamiento), consolidación de estilos de vida, proyectos de pareja y parentalidad.
Adulthood Media (40 a 65 años)	Aparición visible de signos de envejecimiento primario (arrugas, presbicia, pérdida gradual de masa muscular). Transición del climaterio: menopausia en mujeres y andropausia gradual en varones.	Cúspide de las habilidades mentales cristalizadas, pericia práctica y resolución de problemas cotidianos complejos. La producción creativa puede mermar en volumen pero incrementa en calidad conceptual.	Crisis de la mitad de la vida / Generatividad vs. Estancamiento (guiar a las nuevas generaciones). Tensión por doble cuidado ("generación sándwich": atender hijos y padres ancianos) y afrontamiento del "nido vacío".
Adulthood Tardía / Vejez (65 años en adelante) • Joven: 65-74 • Anciano: 75+	La mayoría permanece funcionalmente activa y saludable, aunque declina la capacidad de reserva orgánica y se lentifican los tiempos de respuesta motriz y sensorial.	Alerta mental preservada en la mayoría. Lentificación en la velocidad de procesamiento y memoria episódica, compensada mediante estrategias mnémicas externas y uso del conocimiento pragmático.	Integridad del Yo vs. Desesperación (revisión biográfica integradora). Reorganización del tiempo libre por la jubilación, redefinición de roles comunitarios, elaboración de duelos y afrontamiento de la propia finitud.

3. Sistemas de influencia: modelo bioecológico de Urie Bronfenbrenner y tipología de sucesos

A. Tipos de Influencias sobre el Desarrollo

- **Influencias Normativas Determinadas por la Edad:** Eventos biológicos y socioculturales altamente predecibles que ocurren de forma semejante para la mayoría de los individuos de un mismo rango etario (ej. la menopausia en la biología; el ingreso escolar o la jubilación en lo social).
- **Influencias Normativas Históricas (de Cohorte):** Circunstancias culturales, políticas o económicas que impactan simultáneamente a una generación o cohorte temporal compartida (ej. vivir bajo una dictadura militar, atravesar una hiperinflación o la revolución tecnológica digital).
- **Influencias No Normativas:** Sucesos atípicos que irrumpen en la trayectoria de un sujeto particular, o sucesos normativos que ocurren en un momento del ciclo vital totalmente inesperado (ej. ganar la lotería, quedar viudo a los 25 años, ser padre a los 60 o sobrevivir a un accidente aéreo).

B. Niveles Bioecológicos (Bronfenbrenner)

- **Microsistema:** Escenario cotidiano de interacciones directas cara a cara (el hogar, la pareja, los hijos, el espacio laboral inmediato, el grupo de amigos cercanos).
- **Mesosistema:** Red de interconexiones e influencias mutuas entre dos o más microsistemas del individuo (ej. cómo el estrés o la insatisfacción en el trabajo deteriora el clima conyugal en el hogar).
- **Exosistema:** Entornos e instituciones en los que la persona no participa de forma directa pero cuyas decisiones impactan sobre sus microsistemas (ej. el sistema de transporte público, las políticas de cobertura de salud de las agencias gubernamentales o el horario laboral de la pareja).
- **Macrosistema:** Matriz sociocultural global que engloba las ideologías dominantes, los sistemas económicos (capitalismo, socialismo), los marcos legales y los valores culturales.
- **Cronosistema:** Dimensión temporal que atraviesa todos los niveles, incluyendo las transiciones personales (divorcio, cambios de residencia) y los cambios sociohistóricos macro a lo largo de los años.

4. Envejecimiento Biológico: Teorías Genéticas y de Tasa Variable

Distinción entre Envejecimiento Primario y Secundario

- **Envejecimiento Primario:** Proceso biológico universal, gradual, genéticamente programado e inevitable de deterioro y declive estructural que ocurre a lo largo del tiempo, con independencia de las enfermedades.
- **Envejecimiento Secundario:** Deterioro corporal producto de patologías adquiridas, abusos (tabaquismo, alcoholismo), sedentarismo y factores ambientales nocivos; son factores potencialmente prevenibles, modificables o controlables por el sujeto.

Modelos Teóricos del Envejecimiento Biológico

Enfoque Teórico	Teoría Específica	Mecanismo Fisiológico / Explicación Teórica
Teorías de Programación Genética (El cuerpo sigue un reloj biológico innato e invariable)	Límite de Hayflick / Senectud Programada	Las células humanas en cultivo poseen un número finito de divisiones celulares (~50 réplicas) antes de entrar en senescencia. Los genes se "apagan" deliberadamente según un calendario biológico predeterminado.
	Teoría Inmunológica y Endocrina	El reloj biológico actúa a través de genes que comandan el apagado hormonal y el declive del sistema inmunológico, elevando la vulnerabilidad a infecciones y procesos autoinmunes.
Teorías de Tasa Variable / Tasa del Error (El envejecimiento resulta de daños aleatorios acumulados internos y externos)	Desgaste por el uso (Wear and Tear)	El cuerpo se deteriora por la acumulación continua de agresiones y estrés vital diario; sin embargo, no contempla cabalmente la capacidad del organismo para la autorreparación activa.
	Radicales Libres	Subproductos metabólicos altamente inestables que contienen oxígeno libre reactivo. Oxidan y dañan irreversiblemente membranas celulares, proteínas estructurales y el ADN mitocondrial.
	Tasa de Vida	Existe un límite en la cantidad total de energía metabólica que un organismo puede consumir; a mayor velocidad metabólica basal, más rápido ocurre el agotamiento fisiológico.
	Mutación Somática y Error Catastrófico	Errores aleatorios durante la duplicación celular y el daño acumulado por estresores alteran la síntesis proteica de órganos vitales hasta alcanzar un umbral crítico que induce la falla orgánica masiva.
	Entrecruzamiento (Cross-Linking)	Formación de enlaces químicos cruzados anormales entre moléculas de colágeno y elastina (agravado por hiperglucemia crónica en diabetes), lo cual torna a los tejidos conectivos, vasos sanguíneos y cristalino rígidos e inelásticos.

5. Cambios Fisiológicos, Sensoriomotores y Neurobiológicos en el Adulto Mayor

A. Sistema Nervioso y Lentificación Funcional

- **Cambios Estructurales:** A partir de los 30 años el cerebro experimenta una sutil pérdida de peso acumulada que alcanza hasta el 10% hacia los 80 años. El *cerebelo* puede perder hasta un 25% de sus células neuronales (afectando la coordinación y el equilibrio). Se observa adelgazamiento cortical y deterioro gradual del Sistema Nervioso Autónomo (SNA).
- **Cambios Funcionales:** Lentificación global en la velocidad de conducción nerviosa, enlentecimiento del tiempo de reacción simple y complejo, pérdida progresiva de reflejos y menor tolerancia a temperaturas ambientales extremas (dificultad para regular frío y calor).

B. Cambios Sensoriomotores y Patologías Visuales/Auditivas

- **Visión:**
 - *Presbicia:* Pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino (dificultad para enfocar objetos cercanos después de los 40 años).
 - *Cataratas:* Opacamiento progresivo del cristalino que bloquea el paso de la luz, generando visión nublada y sensibilidad al encandilamiento.
 - *Degeneración Macular Asociada a la Edad (AMD):* Deterioro de la mácula retinal; es la principal causa de ceguera funcional en adultos mayores (90% subtipo seca, 10% subtipo húmeda).
 - *Glaucoma:* Elevación patológica de la presión intraocular por drenaje deficiente del humor acuoso, produciendo atrofia progresiva del nervio óptico.
- **Audición:**
 - *Presbiacusia:* Pérdida auditiva sensorineural bilateral, simétrica y gradual, con afectación selectiva inicial de los tonos de alta frecuencia (sonidos agudos). Más común y precoz en varones.
 - *Tinnitus:* Percepción persistente de zumbidos o tintineos en los oídos en ausencia de estímulos externos (presente en ~10% de adultos mayores).
- **Sistema Músculo-Esquelético:** Sarcopenia (pérdida progresiva de masa muscular reemplazada por tejido adiposo), osteopenia/osteoporosis y rigidez articular. El ejercicio de fuerza y resistencia permite preservar la masa ósea, el equilibrio postural y reduce críticamente el riesgo de caídas y fracturas.

6. Sexualidad, Salud Integral y Demografía

A. Climaterio y Sexualidad en la Adulthood Media y Mayor

- **Menopausia Femenina (45-55 años):** Cese irreversible de la ovulación y la menstruación por agotamiento folicular ovárico y caída de estrógenos/progesterona. Precedida por la perimenopausia. La sexualidad no desaparece; suele asociarse a menor tensión ante el embarazo y a una reconfiguración del placer no centrado exclusivamente en la reproducción.
- **Andropausia Masculina:** Descenso gradual y continuo de los niveles de testosterona (1% anual desde los 30 años; 30-40% acumulado a los 70). Puede acompañarse de hiperplasia prostática y tiempos de refracción eyaculatoria más prolongados. La disfunción eréctil responde mayoritariamente a factores vasculares crónicos (hipertensión, diabetes) o factores psicológicos (ansiedad de rendimiento).

B. Edadismo (Discriminación por Edad) y Salud Mental

El **edadismo** es el conjunto de prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias dirigidas hacia las personas mayores basadas únicamente en su edad cronológica. Incluye estereotipos negativos (asumir que son incompetentes, seniles, asexuados, enfermos crónicos o inflexibles) y estereotipos positivos paternalistas (idealizar una supuesta "edad dorada" de paz pasiva sin anhelos productivos). Ambos distorsionan la atención clínica y el diseño de políticas públicas.

C. Transición Demográfica y Esperanza de Vida en Argentina

- **Distinción Demográfica:** La *expectativa de vida* representa los años promedio que estadísticamente se espera que viva una persona nacida en un contexto y año determinado; la *longevidad* alude a la duración real efectiva de la vida de un individuo.
- **Datos Históricos y Actuales en Argentina:**
 - En 1970: Esperanza de vida global de **65,65 años** (Mujeres: 69,56 años; Hombres: 62,16 años).
 - En 2023: Esperanza de vida global de **77,39 años** (Mujeres: **79,88 años**; Hombres: **74,81 años**).
- **Paradoja del Género:** Las mujeres presentan una mayor sobrevivencia promedio que los varones (debido a factores genéticos, protección hormonal estrogénica previa y mayor conducta de autocuidado y consulta médica temprana); no obstante, viven más años con enfermedades crónicas no fatales y presentan mayor riesgo de soledad, viudez y precariedad económica en la vejez avanzada.
- **El Desafío del Envejecimiento Productivo:** El aumento exponencial de la población mayor de 65 y 85 años exige transformar las economías y los sistemas de salud, promoviendo la inclusión social activa y la autonomía en lugar de la institucionalización pasiva.